Anamnesefragen

Allgemeine Einstiegsfragen

- **Was kann ich für Sie tun?**
- **Was führt Sie zu uns?**

Müdigkeit

- **Seit wann haben Sie Müdigkeit?**
- **Gibt es eine Ursache dafür, dass Sie sich müde fühlen? Vielleicht Schmerzen oder Schlafstörungen?**

Schmerzen – Lokalisation und Charakter

- **Wo genau haben Sie diese Schmerzen?**
- **Sind die Schmerzen symmetrisch?**
- **Seit wann haben Sie diese Beschwerden?**
- **Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?**
- **Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?**
- **Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen?**
- **Sind die Schmerzen dauerhaft oder kommen und gehen sie?**
- **Ist es das erste Mal, oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome?**
- **Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?**
- **Wurden Untersuchungen durchgeführt?**
- **Sind die Schmerzen im Verlauf schlimmer geworden?**
- **Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie stechend oder dumpf?**
- **Wie stark sind die Schmerzen?**
- **Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?**
- **Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen?**
- **Haben Sie Schwellungen, Rötungen oder Überwärmung an den Hand- oder Kniegelenken bemerkt?**
- **Gibt es eine Morgensteifigkeit? Wenn ja, wie lange dauert sie?**
- **Verbessern sich die Symptome im Laufe des Tages?**

Hautveränderungen (SLE-Relevanz)

- **Haben Sie Hautveränderungen im Gesicht oder an anderen Körperstellen bemerkt?**
- **Ist die Hautrötung trocken oder nässend?**
- **Treten die Hautveränderungen nach Sonnenexposition auf?**
- **Wie äußert sich die Sonnenempfindlichkeit?**
- **Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie wunde Stellen im Mund oder an der Nase haben?**
- **Haben Sie Haarausfall bemerkt?**

Kardiopulmonale Symptome

- **Haben Sie in letzter Zeit Brustschmerzen beim Ein- oder Ausatmen, Herzklopfen, Atemnot oder Husten bemerkt?**

Hämatologische Symptome

- **Hatten Sie häufige Infekte, blaue Flecken oder Nasenbluten?**
- **Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ein geschwollenes, gerötetes und überwärmtes Bein haben?**

Neurologische Symptome

- **Haben Sie in letzter Zeit Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen oder Krampfanfälle erlebt?**
- **Gab es Stimmungsschwankungen oder depressive Symptome?**

Nierenbeteiligung

- **Haben Sie Schwellungen an den Beinen oder im Gesicht bemerkt?**
- **Haben Sie Veränderungen beim Wasserlassen festgestellt?**
- **Ist der Urin schaumig?**
- **Haben Sie Blut im Urin bemerkt?**
- **Haben Sie Rückenschmerzen in der Nierengegend?**

Fieber / Systemische Symptome

- **Haben Sie Fieber?**
- **Seit wann?**
- **Haben Sie die Temperatur gemessen?**
- **Wie hoch war sie?**
- **Wo haben Sie gemessen?**
- **Haben Sie Schüttelfrost?**
- **Schwitzen Sie mehr als sonst? Haben Sie Schweißausbrüche oder Nachtschweiß?**

Appetit / Gewicht

- **Wie ist Ihr Appetit?**
- **Haben Sie in letzter Zeit Gewicht verloren?**

Abschlussfrage

- **Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?**

Vorstellung:

ä

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Es geht um Frau Marina Müller. Sie ist 45 Jahre alt, geboren am 08.10.1979. Sie ist 1,71 m groß und wiegt 75,3 kg.
Frau Müller stellt sich bei uns wegen seit zwei Wochen bestehender Müdigkeit und Fieber (38,4 °C) vor. Das Fieber wurde axillär gemessen.

Laut Aussage der Patientin leidet sie unter Arthralgien an den Handgelenken und Kniegelenken seit zwei Wochen. Die Schmerzintensität liegt bei 5/10 auf der Schmerzskala. Die Schmerzen verschlimmern sich bei Belastung, während sie sich in Ruhe und nach der Einnahme von Novalgin 75 mg bessern. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Frau Müller hat auch Morgensteifigkeit, jedoch verschwindet diese nach 30 Minuten. Sie berichtet, dass die Gelenke rubor, tumor und calor zeigen und sie seit fünf Monaten schubweise Arthralgien hat.

Nach Angabe der Patientin hat sie seit zwei Monaten ein Schmetterlingserythem mit Pusteln.

Begleitend klagt sie über Nachtschweiß, Mundulzera und Dysurie.
Die Fragen zu Dyspnoe, Tussis, Brustschmerzen, Tachykardie, Kopfschmerzen, Vertigo, Schwindel, depressiver Verstimmung, Hämatomen und Blutungen wurden verneint.
Vegetativ-anamnestisch ergab sich lediglich eine Gewichtsabnahme von 3 kg in zwei Monaten sowie eine schmerzbedingte Dyssomnie.
Bei der gynäkologischen Anamnese ergaben sich zwei Abortus.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie eine Tonsillitis vor drei Monaten.
Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Voltaren 75 mg, Pantoprazol 20 mg und Minulet.
Die Allergieanamnese war unauffällig.
Bei der Noxenanamnese erwähnte sie lediglich ein bis zwei Gläser Wein am Wochenende. Nikotinkonsum und Drogenkonsum wurden verneint.
Die Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom beim Vater (daran verstorben), eine rheumatoide Arthritis bei der Mutter und Psoriasis bei der Schwester.
Sozialanamnestisch ist sie Sozialarbeiterin/Pädagogin in einer Grundschule von Beruf, verheiratet, wohnt mit ihrer Familie zusammen und hat zwei Kinder.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf einen systemischen Lupus erythematodes hin.
Beidseitige Hand- und Kniegelenkschmerzen mit Entzündung (tumor, calor, rubor), Müdigkeit, Schmetterlingserythem, Gewichtsabnahme, Dysurie, schubweiser Verlauf seit fünf Monaten sowie die Familienanamnese mit rheumatoider Arthritis bei der Mutter und Psoriasis bei der Schwester sprechen dafür.

Differenzialdiagnostisch kommen rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Dermatomyositis, systemische Sklerodermie und Polyarteriitis nodosa in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung vornehmen. Bei der Inspektion werde ich darauf achten, ob ein typisches Schmetterlingserythem im Gesicht, Schwellungen, Rötungen, Fehlstellungen an den Gelenken, Haarausfall und Schleimhautgeschwüre vorliegen. Bei der Palpation achte ich auf Druckschmerzen und Überwärmung der Gelenke sowie auf vergrößerte Lymphknoten und Druckschmerzhaftigkeit im Abdomen; bei der Auskultation auf Reibegeräusche an Herz und Lunge und bei der Perkussion auf einen gedämpften Klopfschall bei Pleuraerguss.

Anschließend werde ich ein EKG schreiben, um die Herzaktivität zu überprüfen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.

Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter (CRP, BSG, ggf. PCT), Komplementfaktoren, den Coombs-Test (hämolytische Anämie), ANA-Titer (antinukleäre Antikörper > 1:80, spezifisch für SLE), Anti-dsDNA, Anti-Smith-Antikörper (spezifisch für SLE), Elektrolyte, Nieren- und Leberwerte sowie einen Urinstatus (Proteinurie und Erythrozyturie) bestimmen lassen.
Anschließend werde ich eine Röntgenaufnahme der Gelenke und einen Ultraschall der Nieren durchführen, eine Hautbiopsie (Lupusband-Test) und ggf. eine Nierenbiopsie (Bestätigung einer Lupusnephritis) veranlassen sowie ein Konsil bei der Abteilung für Rheumatologie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:
Die Patientin sollte stationär aufgenommen werden.
Die weitere Therapie hängt davon ab, wie die Krankheit verläuft.
Bei leichtem Verlauf ohne Beteiligung lebenswichtiger Organe werden der Patientin NSAR, Hydroxychloroquin und Glukokortikoide bei entzündlichen Schüben verordnet.
Bei schwerem Verlauf mit Beteiligung lebenswichtiger Organe werden der Patientin Glukokortikoide und ggf. zusätzlich Azathioprin, alternativ Methotrexat, weitere Immunsuppressiva (z. B. Cyclophosphamid, Ciclosporin, Mycophenolatmofetil) sowie Biologicals wie Belimumab verordnet.
Sonnenexposition zu vermeiden und die Anwendung von Lichtschutzsalbe werden empfohlen.

❄ Raynaud-Phänomen (SLE, Sklerodermie, MCTD ayırıcı tanı için)

- **Werden Ihre Finger bei Kälte weiß, blau oder rot?**

🌿 Diğer bağ dokusu hastalıklarını dışlamak için sorular

Sklerodermie taraması:

- **Haben Sie eine Hautverhärtung oder Hautstraffung bemerkt?**
- **Öffnet sich Ihr Mund schlechter als früher?**
- **Haben Sie häufig Sodbrennen oder Schluckbeschwerden?**

Sjögrén-Syndrom taraması:

- **Haben Sie trockene Augen?**
- **Haben Sie einen trockenen Mund oder Probleme beim Schlucken?**

Mischkollagenose / MCTD:

- **Haben Sie Muskel- oder Sehnenschmerzen?**
- **Gibt es Schwellungen an den Fingern?**

⭐ SLE – RA Farkları (En Önemli Noktalar)

1️⃣ Eklem bulguları

RA:

- **Simetrik, erozif, destrüktif artrit**
- Kalıcı eklem deformiteleri (**Schwanenhals, Knopfloch**) olabilir
- Kronik seyir, eklemlerde yapısal hasar

SLE:

- **Non-erosive artritis** (yıkıcı değildir)
- Şişlik ve ağrı olur ama **kemik erozyonu yoktur**
- Deformiteler nadirdir ve genelde **reversibel**dir (Jaccoud-Arthropathie)

---

2 Sistemik tutulum

SLE:

- **Çoklu organ tutulumu**:
  → Cilt (malaraş, fotosensitivite)
  → Böbrek (lupus nefriti)
  → Hematolojik (anemi, trombositopeni, lökopeni)

→ Nörolojik (kriz, psikoz)
→ Serözit (pleurit, perikardit)

RA:

- Sistemik bulgular olabilir ama SLE kadar geniş değildir.
- Eklem dışı bulgular:
  → Lunge: Rheumaknoten, interstitielle Pneumonie
  → Augen: Sicca-Syndrom (Sjogren ile ilişkili)
  → Gefäße: Vaskulitis nadir

---

3 Laboratuvar

RA tipik lab:

- **RF** (+) olabilir
- **Anti-CCP** (yüksek spesifik)
- Yüksek CRP, BSG

SLE tipik lab:

- **ANA pozitif** (neredeyse tüm hastalarda)
- **Anti-dsDNA, Anti-Sm** (spesifik)
- **Komplement düşük (C3, C4)**
- Hematolojik sitopeniler sık

---

4 Cilt bulguları

RA:

- Tipik bir deri döküntüsü yok

SLE:

- **Schmetterlingserythem (malar rash)**
- Diskoid lezyonlar
- Fotosensitivite
- Ağız ülserleri

5️⃣ Böbrek tutulum farkı

SLE:

- Böbrek tutulumu çok yaygın (**Lupus Nephritis**)
- Proteinüri, hematüri

RA:

- Böbrek tutulumı nadir, genelde ilaçlara bağlı (NSAID, DMARD)

---

6 Cinsiyet ve yaş

SLE:

- Genç kadınlarda çok daha sık
- 20–40 yaş

RA:

- Orta yaş başlangıç
- Kadınlarda daha yaygın ama SLE kadar belirgin değil

⭐ Mini Klinik Özet (FSP için):

„SLE zeigt ein nicht-erosives, reversibles Arthritismuster und eine ausgeprägte Multiorganbeteiligung (Haut, Niere, Blut, Serosa), während die RA eine erosiv-destruktive Polyarthritis mit typischen Deformitäten und Anti-CCP-Positivität ist.“

✅ Coombs-Test (Antiglobulin-Test)

Yazdığın **“commbst etst”** → büyük ihtimalle yazım hatası 🙂

◆ Coombs Testi Nedir?

Bağışıklık sisteminin, **alyuvarlara (eritrositlere) karşı antikor üretip üretmediğini** gösteren bir testtir.

İki türü var:

1️⃣) Direkt Coombs Testi (Direkter Antiglobulintest – DAT)

👉 Eritrositlerin üzerine bağlanmış antikorları saptar.

2) İndirekt Coombs Testi

👉 Kanda serbest dolaşan antikorları gösterir
(özellikle kan transfüzyonu ve gebelikte kullanılır).

◆ SLE'de Neden Önemli?

Çünkü SLE'de:

👉 **Otoimmün hemolitik anemi (AIHA)** sık görülebilir.

Bağışıklık sistemi alyuvarlara saldırır →
alyuvarlar parçalanır → hemoliz olur.

Coombs testi:

✅ Bu hemolizin otoimmün kaynaklı olduğunu kanıtlar.

SLE'de tablo şöyle olur:

- Hb düşer
- LDH ↑
- Bilirubin ↑
- Haptoglobin ↓
- **Direkt Coombs POZİTİF**

➡ Tanı: *SLE'ye bağlı otoimmün hemolitik anemi*

◆ Klinik önemi

Coombs testi sayesinde:

1. Aneminin nedeni netleşir
2. Tedavi yönlendirilir
    - Kortizon
    - immünsüpresif tedavi
3. Transfüzyon planı yapılır

Sınav için altın cümle (Almanca)

„Der Coombs-Test ist bei SLE wichtig, weil er eine autoimmune hämolytische Anämie nachweist. Ein positiver direkter Coombs-Test zeigt, dass Antikörper an den Erythrozyten gebunden sind.“

Eine Pustel ist eine kleine Blase mit Eiter.
Ein Bläschen ist eine kleine Hauterhebung mit klarer Flüssigkeit.
Eine Schuppe ist eine trockene, lockere Hautablösung(CİLT SOYULMASI).
Schuppen sieht man oft bei trockener Haut oder Psoriasis.

Immun System greif eigene Körper an.

Düsseldorf Fall#20/28.11.2024/Nabil Protokolle

(Für Beide Prüfungen FSP& Kenntnis)

Systemischer Lupus erythematodes (SLE)

Persönlichen Daten	Marina Müller 45 J., 08.10.1979 75,3 kg 1,71m	
Aktuelle Beschwerden	o Müdigkeit, Fieber (38,4 °C axillär), Seit gestern o Gelenkschmerzen, seit 2 Wochen (Handgelenke, Knie beidseits; 5/10 bei Belastung, 4/10 in der Ruhe) Einnahme von Novalgin 75mg b.B., hilfreich o **Gesichtsrötung** mit Sonnenempfindlichkeit (Schmetterlingserythem, mit Bläschen /mit Pusteln), seit 2 Monaten ✓ Mein Hausarzt dachte, dass es sich um eine Infektion handelt. Er hat mir empfohlen, in die Klinik zu gehen. ✓ Das war eine gute Entscheidung. Wir werden jetzt notwendigen Untersuchung durchführen, um die Ursache abzuklären	(Ich fühle mich Müde und habe seit gestern Fieber). (Man soll viele Frage stellen) Frage zum Hausarztbesuch? „Mein Hausarzt dachte, dass es sich um eine Infektion handelt, und hat mir empfohlen, in die Uniklinik zu gehen" Wichtige Frage: **Ist die Hautrötung trocken oder nässend?** •**Trocken:** Beschreibt eine Rötung ohne Flüssigkeitsabsonderung. salgi, desoj •**Nässend:** Beschreibt eine Rötung, die mit Sekretaustritt oder Flüssigkeitsbildung verbunden ist.
Begleitsymptome	o Nachtschweiß o Wunde im Mund (Mundulzera) ± o Schubweiser Verlauf seit 5 Monaten ±	***Cave: Nach Lehrbüchern*** o Brustschmerzen o Kopfschmerzen o Krampfanfällen o Depressionen o Bein Schmerzen (Kribbeln)
Veg. Anamnese	o Schmerzen beim Wasserlassen (Dysurie) ± • Gewichtverlust (3 kg/5kg innerhalb von 2 Monaten). • Schlafstörungen durch Schmerzen o	o grippeähnliche Beschwerden o kann aufgrund der Schmerzen nicht gut schlafen
Gynäkologische Anamnese	o Zwei Fehlgeburten	
Vorerkrankungen	o Tonsillitis vor 3 Monaten Reaktion-> Achsel das habe ich notiert. Danke für die Informationen	Mandelentzündung (Mehrmals wegen wiederkehrender Infektionen zum Hausarzt gegangen)
Operation	Unauffällig	±Mandelentfernung vor 3 Monaten

Wer hat das Ihnen verschrieben? Bitte nehmen Sie keine Medikamente ohne ärztliche Rat ein

Medikamente	○ Voltaren 75 mg ○ Pantoprazol 20 mg ○ Minulet (Antibabypille) der Rat **„Haben Sie Voltaren mit einem Rezept vom Hausarzt eingenommen? „** Haben Sie das Medikament in der Apotheke gekauft/geholt?	**Voltaren 75 mg** enthält den Wirkstoff **Diclofenac** und gehört zur Gruppe der **nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR).** **Cave:** (Verschreibungspflicht) **Minulet** ist eine Antibabypille, die zur Gruppe der **kombinierten oralen Kontrazeptiva** gehört. Sie enthält zwei Hormone: • **Gestoden** (ein Gestagen) • **Ethinylestradiol** (ein Östrogen)
Allergie	Unauffällig	±Als Kind Pollenallergie behandelt mit Eigenbluttherapie
Familienanamnese	○ Vater: Bronchialkarzinom (verstorben) ○ Mutter: Rheumatoide Arthritis ○ Schwester: Psoriasis	
Sozialanamnese	○ Sozialarbeiterin/ Pädagogin in einer Grundschule ○ Verheiratet ○ 2 gesunde Kinder	
NOXEN	○ Nikotinkonsum: Nichtraucherin ○ Alkoholkonsum: 1 – 2 Gläser Wein am Wochenende ○ Drogenkonsum: verneint	Mit Positive Reaktion!
Impfung & Reise	○ Vollständig geimpft ○ Reisen in den letzten 6 Monaten- unauffällig	
Fragen	○ SLE-Komplikationen? ○ Warum denken Sie über SLE? ○ Was ist Pathophysiologie von VHF? ○ Erklären Sie die verschiedenen Arten von Lupus. ○ Sie fragten nach dem Schmetterlingsausschlag bei Lupus. ○ Welche Organe betrifft Lupus? ○ wie Lupus die Nieren betrifft? ○ Was ist das Nierenkörperchen und welche laborchemischen Manifestationen kann Lupus in den Nieren haben? ○ im Herzen und in der Lunge? „Sie fragten, an welche Autoimmunerkrankungen man bei einer jungen Frau denken sollte, worauf ich mit Lupus antwortete." Juncunke	Fragen von Patienten*innen Was habe ich? Was machen Sie jetzt? Wie lange soll ich hierbleiben? ---------- Was sind die Anderen Namen des 1. Und 2. Wirbels? = Atlas& Axis Welchen Impfungen werden in Deutschland ab 60 Jahre empfohlen? (Influenza und Pneumokokken) Cave: Welche Manifestationen hat Lupus Häufig betroffene Gelenke bei SLE: • Kleine Gelenke der Hände: • Fingergrundgelenke (MCP-Gelenke)

dass kann sein, aber nicht jeder bekommt die Krankheit

	Was ist neben den Haftbeschwerden wichtig? **(Familiäre Desposition)** Welchen gelenken sind häufig betroffen? (Metacarpophalangeal, und Proximal interphalangeal)	• Fingermittelgelenke (PIP-Gelenke) • Handgelenke (Radiokarpalgelenke) • Kniegelenke • Schultergelenke • Sprunggelenke • Fußgelenke und Zehengelenke
VD	**Systemischer Lupus erythematodes (SLE)**	-Kriterien: Arthritis, Schmetterlingserythem, Müdigkeit, Mundulzera, Gewichtsverlust. -Familienanamnese spricht für Autoimmunerkrankungen.
DDx	**Rheumatoide Arthritis:** Aufgrund Gelenkschmerzen und familiärer Disposition. **Psoriasis-Arthritis:** Schwester hat Psoriasis. **Infektionen:** Z.B. Endokarditis oder reaktive Arthritis. **Morbus Still (AOSD):** Systemische Entzündung, jedoch weniger typisch.	Nach Lehrbüchern: ◊ Rheumatoide Arthritis ◊ Dermatomyositis ◊ Systemische Sklerodermie ◊ Polyarteriitis nodosa

Diagnostik	Therapie
Für Prüfung ○ Körperliche Untersuchung: **1.Inspektion (Beobachtung):** • **Haut:** Rötungen, typisches Schmetterlingserythem im Gesicht, Hautausschläge. • **Gelenke:** Schwellungen, Rötungen, Fehlstellungen (z. B. Jaccoud-Arthropathie). • **Haare:** Haarausfall (Alopezie). • **Mund:** Schleimhautgeschwüre. **2. Palpation (Abtasten):** • **Gelenke:** Druckschmerz, Schwellung, Überwärmung • **Lymphknoten:** Vergrößerte Lymphknoten (Lymphadenopathie) • **Bauch:** Schmerzhaftigkeit (z. B. bei Serositis/Peritonitis) **3. Auskultation (Abhören):** → Sorbonnesasi • **Herz:** Reibegeräusche (Hinweis auf Perikarditis), Herzgeräusche (Valvulopathie). • **Lunge:** Reibegeräusche (Pleuritis), verminderte Atemgeräusche (Pleuraerguss). **4. Perkussion (Abklopfen):** • **Lunge:** Gedämpfter Klopfschall bei Pleuraerguss. • **Bauch:** Hinweis auf freie Flüssigkeit bei Aszites (selten). ○ Blutuntersuchung: größer gleich eins zu achtzig • ANA-Titer (antinukleäre Antikörper ≥1:80, spezifisch für Lupus). • Anti-dsDNA, Anti-Smith-Antikörper (spezifisch für SLE).	• **Allgemein** ○ Meiden von Sonnenexposition ○ Lichtschutzsalbe • **Medikamentös** • Bei leichtem Verlauf ohne Beteiligung lebenswichtiger Organe • NSAR • Hydroxychloroquin • Glucocorticoide bei entzündlichen Schüben • Bei schwerem Verlauf mit Beteiligung lebenswichtiger Organe • Glucocorticoide • Evtl. zusätzlich Azathioprin, alternativ • Methotrexat (Off-Label Use) • Weitere Immunsuppressiva (z.B. Cyclophosphamid, Ciclosporin, Mycophenolatmofetil) • Biological: Belimumab

- BSG, CRP (Entzündungsmarker), Komplemente (C3, C4).
- Coombs-Test (hämolytische Anämie).

○ Urinstatus:
- Proteinurie und Erythrozyturie (Nierenbeteiligung)

○ Bildgebung:
- Röntgen der Gelenke.
- Ultraschall der Nieren.

○ Biopsie:
- Haut: Lupusband-Test.
- Nieren: Bestätigung einer Lupus-Nephritis

Sowohl eine UV-Lichttherapie als auch eine UV-Photo(chemo)therapie (PUVA) sind wegen Photosensibilität kontraindiziert!

Wichtige Fragen

Vergessen Sie nicht, nach Niere, Lunge, Herz und ZNS zu fragen.

Haben Sie in letzte Zeit Veränderungen bei Ihrer Urinproduction bemerkt, wie z.B. Schwellungen, Blut im Rin oder einen starken Anstieg der Urinmenge?

Haben Sie in letzter Zeit Brustschmerzen, Atemnot oder Herzklopfen bemerkt? Hatten Sie jemals Episoden von Herzrhythmusstörungen oder Schwellungen in den Beinen?

Haben Sie Atembeschwerden, Husten oder brustschmerzen, insbesondere beim Atmen oder Husten?

Haben Sie in letzter Zeit Kopfschmerzen, Schwindel oder Veränderungen im Sehvermögen erlebt?

Innere Organe:

- Bei Befall der Nieren spricht man von einer Lupus-Nephritis (meist eine Glomerulonephritis).
- Sie tritt bei der Hälfte der Patienten auf und kann bis zum Nieren-versagen führen.
- Auch die Lungen können befallen wer- den (Pleuritis, Lupus-Pneumonie), ebenso das Herz (z.B. Endokarditis, Perikarditis, Myokarditis, Klappenschäden, Herzinfarkt).
- **Nervensystem:** Bei Entzündungen im **ZNS** kommt es zu Kopfschmerzen, Krampfanfällen, Depressionen oder Psy- chosen. Bei Entzündungen im peripheren Nervensystem (**PNS**) droht eine Polyneuropathie.

Extra Info:

Fehlgeburten= **Abortus**: Medizinischer Begriff für Fehlgeburt

•**Spontanabort**: Eine natürliche Fehlgeburt, die ohne äußere Eingriffe oder erkennbare Ursachen auftritt.

•**Frühabort**: Fehlgeburt vor der **12. Schwangerschaftswoche (SSW)**.

•**Spätabort**: Fehlgeburt zwischen der **12. und 24. SSW**.

•**Abortus imminens**: Drohende Fehlgeburt; die Schwangerschaft besteht noch, aber es treten Symptome wie Blutungen auf.

•**Abortus incompletus**: Unvollständige Fehlgeburt, bei der Gewebereste in der Gebärmutter verbleiben.

•**Abortus completus**: Vollständige Fehlgeburt, bei der alle Schwangerschaftsprodukte ausgeschieden wurden.

Cave: extra Info;

○ Die Symptome hängen stark davon ab, welche Organsysteme betroffen sind,

○ Haut: **empfindlich auf Sonneneinstrahlung**

○ **Infektion** als auslösender Faktor

○ **Allgemeinsymptomatik:**
- Die Patientin fühlt sich krank

und haben grippeähnliche Beschwerden mit Fieber.

○ **Gelenke:** Bei 90% der SLE-Patienten kommt es zu einer **Arthritis** und/oder **Arthralgie** (Gelenkschmerzen) eines oder mehrerer Gelenke. Am häufigsten sind die Hände (v.a. die Mittelfingergelenke) und die Kniegelenke betroffen.

Gelenkknorpel und Knochen werden zwar nicht zerstört, aber die Schmerzen können trotzdem erheblich sein.

	Durch Sehnen- oder Muskelbeteiligung können Verformungen auftreten. Deformitäten **Haut:** Bei 80% der SLE-Patienten ist die Haut befallen. Es kommt zu der typischen schmetterlingsförmigen Rötung **im Gesicht** mit Pusteln (**Schmetterlingserythem)** Auch am Körperstamm können Erytheme auftreten. Die Haut reagiert insgesamt **empfindlich auf Sonnen- einstrahlung** (Photosensitivität). An Körper und Gesicht können vernarbende Plaques, Hautblasen und Ulzerationen (Geschwüre) auftreten. In Mund und Nase kommt es häufig zu Schleimhautgeschwüren. 2/3 der Patienten leiden unter Haarausfall. Auch an den Rückseiten der Finger finden sich häufig gerötete Stellen und Plaques. •

Anamnesebogen – Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Patient/ Patientin

Marina Müller
45 J. ,08.10.1979
75,3 kg
1,71 m

Datum

06.11.2024

Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)

Rahmensetz

Aktuelle Beschwerde

- Malaise, Seit 2 Wochen
- Fieber (38,4 °C axillär), Seit gestern
- Arthralgie (Hände & Kniegelenke) 5 von 10 NRS, seit 2 Wochen
- Ausstrahlung: ohne
- Schmetterlingserythem (mit Pusteln), seit 2 Monaten
- o Schubweiser Verlauf seit 5 Monaten

Begeleitsymptome:

- Nachtschweiß
- Mundulzera

vegetative Anamnese

- Gewicht Abnahme, 5 Kg innerhalb 2 Monaten
- Insomnie und Dysomnie

Vorerkrankungen

- Tonsillitis vor 3 Monaten

OP

- Unauffällig

Medikamente

- Voltaren 75 mg b.B.
- Pantoprazol 20 mg b.B.
- Minulet 0-0-1

Allergien/ Unverträglichkeiten

- unauffällig

Genussmittel/ Drogen

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: 1 – 2 Gläser Wein am Wochenende
- Drogenkonsum: verneint

Sozialanamnese

- Sozialarbeiterin in einer Grundschule / Pädagogin in einer Grundschule
- Verheiratet
- 2 gesunde Kinder

Familienanamnese

- Vater: Bronchialkarzinom (verstorben)
- Mutter: Rheumatoide Arthritis
- Schwester: Psoriasis

Verdachtsdiagnose

- Systemischer Lupus erythematodes (SLE)

Differentialdiagnose

- ◊ Rheumatoide Arthritis + Psoriasis - Arthritis (Schuppenflechte mit Gelenkbeteiligung)
- ◊ Dermatomyositis
- ◊ Systemische Sklerodermie
- ◊ Polyarteriitis nodosa

Psoriasis - Schuppenflechte..

weitere Procedere

- **KU**
- **Blutuntersuchung:**
- ANA-Titer (antinukleäre Antikörper ≥1:80, spezifisch für Lupus).
- Anti-dsDNA, Anti-Smith-Antikörper (spezifisch für SLE).
- BSG, CRP (Entzündungsmarker), Komplemente (C3, C4).
- Coombs-Test (hämolytische Anämie).
- **Urinstatus:**
- Proteinurie und Erythrozyturie (Nierenbeteiligung).
- **Bildgebung:**
- Röntgen der Gelenke.
- Ultraschall der Nieren.
- **Biopsie:**
- Haut: Lupusband-Test.
- Nieren: Bestätigung einer Lupus-Nephritis

- **Therapievorschläge**

Allgemein

- Sonnenexposition meiden
- Lichtschutzsalbe

Medikamentös

- Bei leichtem Verlauf ohne Beteiligung lebenswichtiger Organe
- NSAR
- Hydroxychloroquin
- Glucocorticoide (bei entzündlichen Schüben)

Es wäre besser für Ihre Gesundheit, wenn Sie jeden Tag regelmäßig mindestens 30 Minuten Sport treiben oder spazieren gehen.

Patientin

Marina Müller
45J.
* 08.10.1979
1,71 m 75,3 kg

Hauptbeschwerden

- seit 2 Wochen bestehende, progrediente Müdigkeit
- Fieber (seit gestern, ~~oral~~ axillär, 38,4°C)
- seit 2 Wochen bestehende, langsam aufgetretene, progrediente, persistierende, ziehende, beidseitige Arthralgie an den Handgelenken und Kniegelenken
- Auslöser: keine
- die Schmerzintensität: 4/10 auf der NRS in der Ruhe
  5/10 auf der NRS bei Belastung
- ohne Ausstrahlung
- verstärkte Faktoren: Bewegung
- lindernde Faktoren: nach Einnahme von Voltaren 75mg
- ähnliche Beschwerden: seit 5 Monaten, schubweise
- Morgensteifigkeit (Dauer: 15-20 Minuten)

Begleitsymptome

- Schmetterlingerythem (seit 2 Monaten, trockend, mit Pustel)
- Schleimhautgeschwür im Mund
- ~~Hydrose~~ Hypohydrose
- Dysurie seit 3 Tagen

~~Ana~~ vegetative Anamnese

- Inappetenz
- Gewichtsabnahme von 3 kg innerhalb 2 Monaten

gynekologische Anamnese

- die letzte Monatsblutung vor 20 Tagen, regelmäßig
- 2 Abortus (erstes Mal vor 10 Jahren, zweites Mal vor 8 Jahren)

Vorerkrankungen

- rezidivierende Tonsillitis vor 3 Monaten

OP

- Tonsillektomie vor 1 Monat

Medikamente

- Voltaren 75 mg b.B
- Pantoprazol 20 mg b.B
- Pille (0-0-1)

Allergien / Unverträglichkeiten

Pollen in der Kindheit (mit Eigenblusttherapie behandelt)

Genussmittel

Nikotinkonsum: Ø

Alkoholkonsum: 1-2 Gläser Wein am Wochenende

Drogenkonsum: Ø

Sozialanamnese

- Sozialarbeiterin
- verheiratet
- 2 Kinder (gesund)

Familienanamnese

Vater: verstorben an Bronchialkarzinom

Mutter: Rheumatoide Arthritis

Schwester: Psoriasis

Verdachtsdiagnose

SLE Systemische Lupus erythematodes
erythematodes

Differentialdiagnose

Rheumatoide Arthritis

Psoriasis - Arthritis

Weitere Procedere

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor → BB, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Komplement (CH, C3), Antikörper (ANA, Anti-dsDNA, Anti-Smith)
- Röntgen-Thorax in 2 Ebenen
- Urin Status
- Sonographie - Nieren
- Rheumatologisches Konsil

Therapie

- stationäre Aufnahme
- NSAR
- Hydrochloroquin
- Glukokortikoid bei Schüben
- Sonnenexposition vermeiden
- Lichtschutzsalbe

ambulante Behandlung

Patientenschulung { Sonnenexposition vermeiden (Lichtschutzsalbe)

NSAR

Glukokortikoid bei Schüben

Hydroxychloroquin

Hydroxychloroquin

Paraungualle Telangiektasien sind erweiterte Kapillaren im Bereich der Nagelfalze und ein typisches Zeichen bei Kollagenosen wie systemischer Sklerose oder Dermatomyositis (1)

Kollagenosen sind systemische Autoimmunerkrankungen des Bindegewebes.

Sicca Syndrom: trockene Augen
" Mund
Haut

Der Coombs-Test ist bei SLE wichtig, weil er eine autoimmune hämolytische Anämie nachweist. Ein positiver direkter Coombs-Test zeigt, dass Antikörper an den Erythrozyten gebunden sind.

Kriterien

ACR / EULAR Kriterien des SLE — ≥ 1 Kriterien und insgesamt ≥ 10 Punkte

Eintrittskriterium → + ANA Titer

Dermatologisch
Systemisch → Gelenkbeteiligung
Neurologisch
Serositis
Nierenbeteiligung
Fieber
Laborchemisch — Hämatopoetisches System
Immunologische Befunde

SLICC Kriterien des SLE

Hemmen heute oft benutzt.

ANA → Hohe Sensitivität 0,99 S
geringe Spezifität

Anti-dsDNA-Antikörper → hoch spezifisch 0,70
mit Lupus Nephritis

Anti-Sm-Antikörper → hoch spezifisch 0,30

Anti-SSA (Ro)-Antikörper → Assoziiert mit Sjögren Syndrom 0,60 SLE

Anti-Phospholipid-Antikörper → mit Antiphospholipid Syndrom 0,25-0,5

Komplikationen

SLE kann zu Lupusnephritis, ZNS-Beteiligung, Zytopenien, Serositis, kardiopulmonalen Komplikationen, ~~Throm~~ Thrombosen und Infektionen führen

VHF Pathophysiologie

Vorhofflimmern entsteht durch ungeordnete elektrische Aktivität in den Vorhöfen mit multiple Reentry-Kreisen, was zu einer ineffektiven Vorhofkontraktion führen

Verschiedene Arten von Lupus

Es gibt systhemischen Lupus erythematodes
kutanen Lupus (discoid)
medikamenteninduzierten Lupus (Hydralazin, Procainamid)
neonatalen Lupus

Schmetterlingausschlag

Ein erythematöses, symmetrisches Exanthem über Wangen und Nasenrücken, typisch für SLE

Welche Organe betrifft SLE?

Haut, Gelenke, Lungen, Herz, Nieren, ZNS, Blut, Gefäße

Wie betrifft Lupus die Nieren?

Durch Immunkomplexablagerungen in den Glomeruli, die zu Entzündung und Funktionsstörung führen (Lupusnephritis)

Nierenkörperchen welche Laborveränderungen

Nierenkörperchen besteht aus Glomerulus und Bowman-Kapsel, Lupus verursacht Proteinurie, Hämaturie, Zylinder und evtl. Kreatininanstieg.

Herzen / Lungen

Am Herzen können Perikarditis, Myokarditis und eine Libman-Sacks Endokarditis auftreten
In der Lunge können Pleuritis, eine interstitielle Lungenerkrankung und eine pulmonale Hypertonie auftreten.